Boletín Epidemiológico N° 29 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

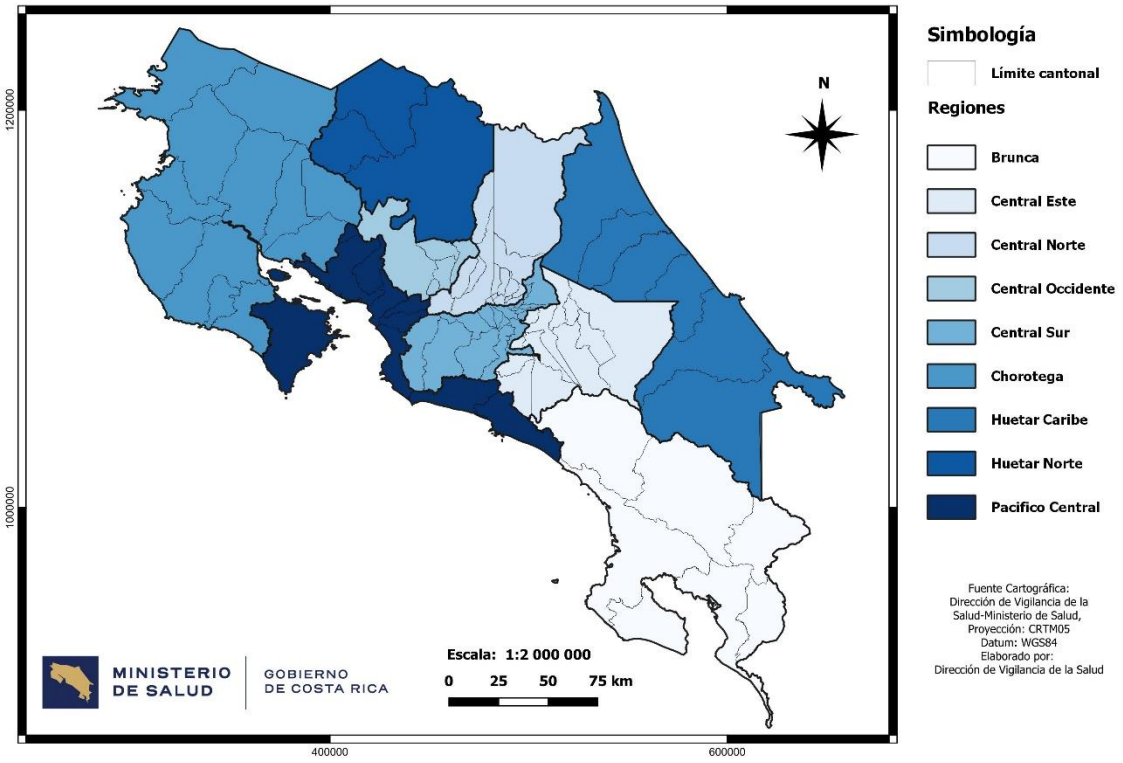
Ministerio de Salud

8 de agosto de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3
Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 30 .. 9
Malaria 11
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 20
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda 35
Meningitis 39
Infecciones de transmisión sexual 43
Miasis por gusano barrenador en humanos 56

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

A la semana epidemiológica 30 del año 2025 se notifican **2758 casos** de dengue, de estos 29 acumulados notificados con signos de alarma.

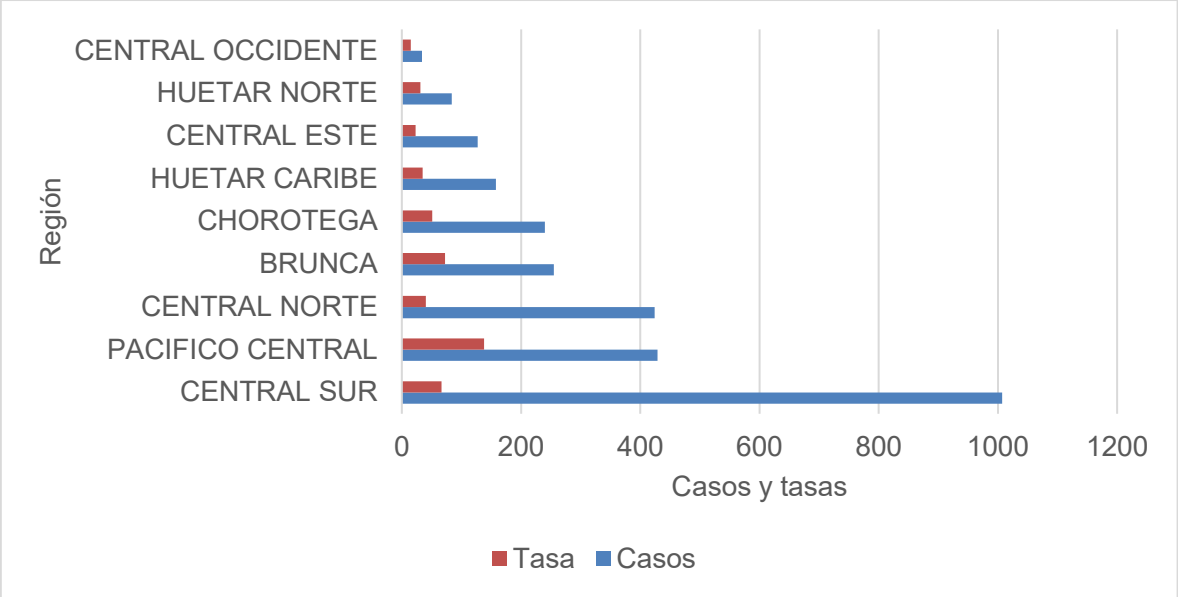
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 1007 casos y la tasa más alta en la Pacífico Central 137,8/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 30, 2025 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Sur	1007	66,7
Pacifico Central	429	137,8
Central Norte	424	40,5
Brunca	255	72,2
Chorotega	240	51,0
Huetar Caribe	158	34,7
Central Este	127	23,0
Huetar Norte	84	31,2
Central Occidente	34	15,2
Total	2758	53,1

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 30, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

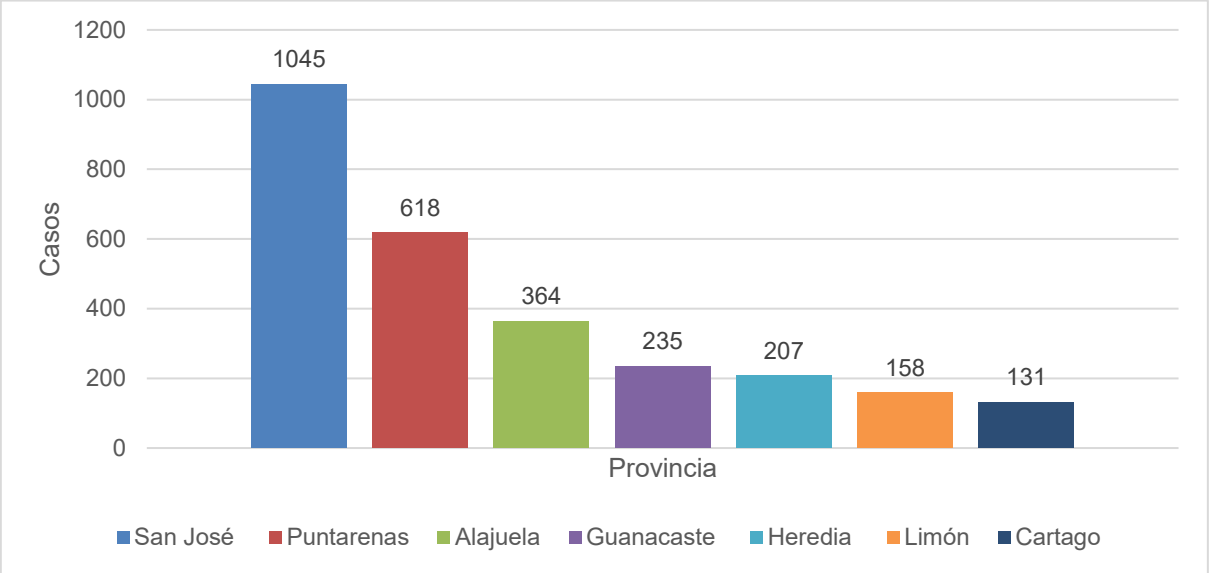
En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2025.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2025

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	1045	62,9	542	64,3	503	61,4
Puntarenas	618	122,2	276	110,4	342	133,8
Alajuela	364	33,9	188	35,1	176	32,7
Guanacaste	235	56,8	102	49,7	133	63,8
Heredia	207	37,9	98	35,7	109	40,1
Limón	158	34,7	71	31,9	87	37,3
Cartago	131	24,6	51	19,0	80	30,2
Total	**2758**	**53,1**	**1328**	**51,1**	**1430**	**55,2**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 30, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 30 son: San José 615 casos, Alajuela 161 casos, Puntarenas 145 casos, Esparza 139 casos, y Sarapiquí 107 casos.

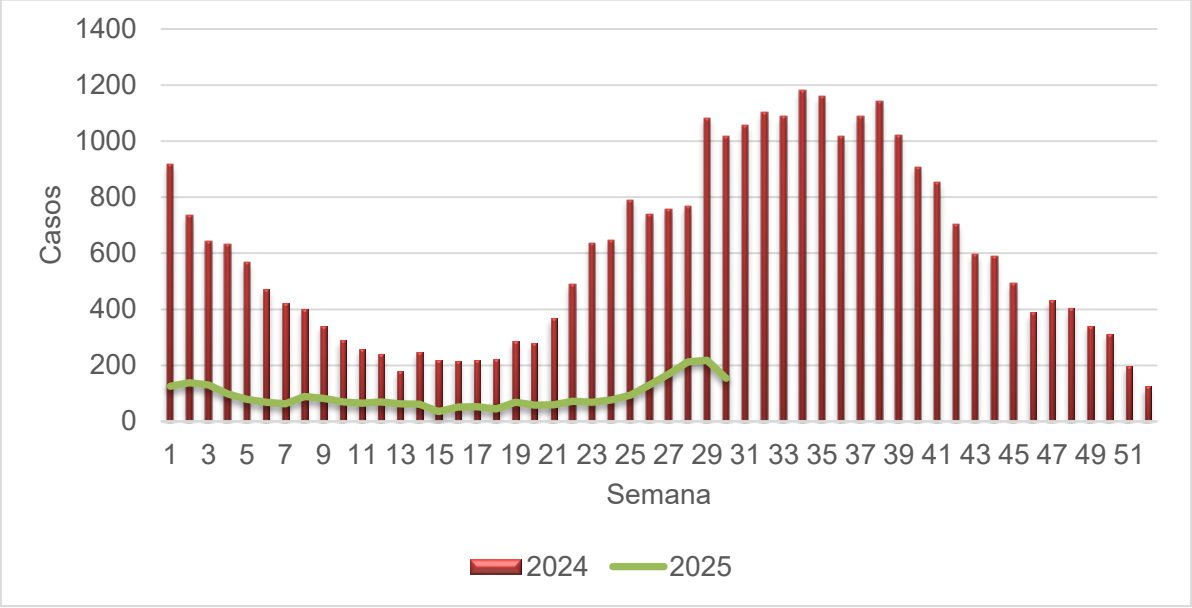
Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 30, 2025.

Cantón	Casos	Tasa
101: San José	615	174,1
201: Alajuela	161	49,1
601: Puntarenas	145	100,4
602: Esparza	139	391,5
410: Sarapiquí	107	110,9
103: Desamparados	89	36,3
610: Corredores	89	166,8
110: Alajuelita	82	84,1
605: Osa	62	210,4
109: Santa Ana	56	90,1
401: Heredia	50	34,1

609: Parrita	49	217,4
210: San Carlos	46	21,7
305: Turrialba	43	62,6
502: Nicoya	43	72,9
119: Pérez Zeledón	42	31,4
604: Montes de Oro	42	280,7
607: Golfito	42	131,3
505: Carrillo	41	82,2
701: Limón	38	41,3

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

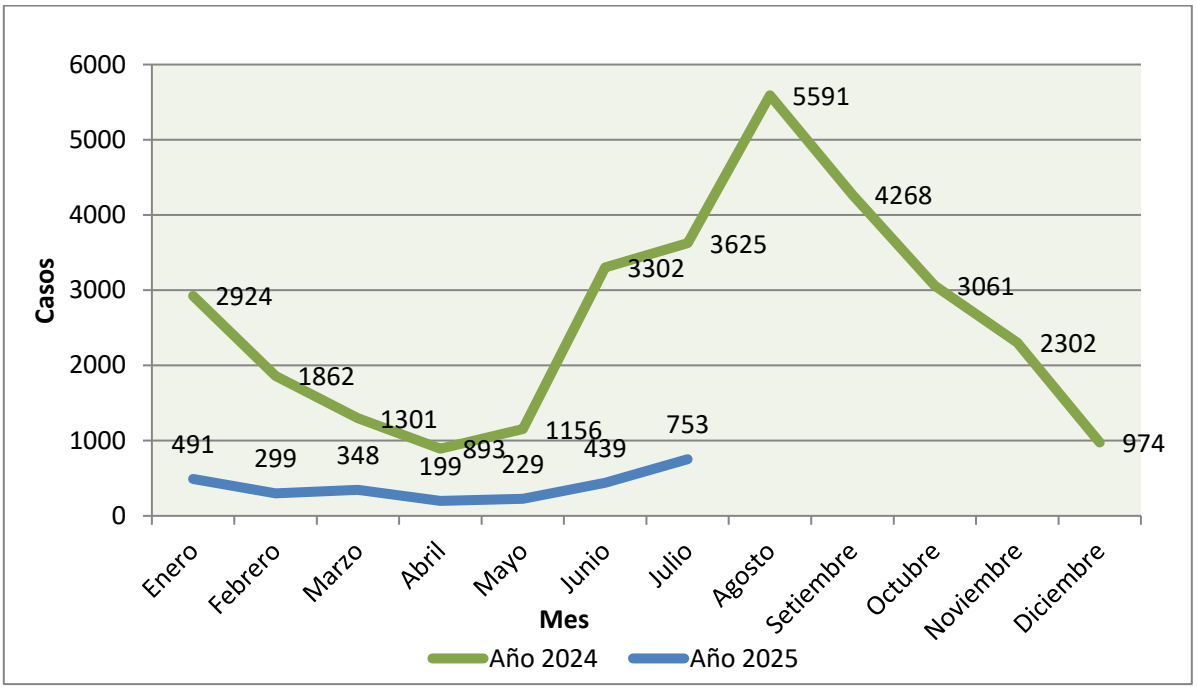
Figura 3.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 30, 2024-2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

En el mes de julio se observa un incremento en la notificación de casos de dengue con respecto a la incidencia reportada en los meses anteriores.

Figura 4.
Costa Rica: casos de dengue notificados por mes, 2024-2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

A la semana epidemiológica 30 del 2024 se reportó un total de 15063 casos de dengue, para este 2025 se reportan 2758 para un descenso en el número de casos notificados del 81,7% con respecto a la misma semana epidemiológica.

Tabla 4.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 30, 2024-2025.

Semana	2024	2025
1	917	125
2	735	138
3	641	130
4	631	98
5	568	79
6	472	68
7	421	63
8	401	89
9	340	82
10	289	69
11	256	65

12	238	69
13	178	63
14	247	61
15	216	35
16	214	51
17	216	52
18	223	44
19	285	68
20	280	58
21	368	59
22	489	72
23	636	68
24	648	76
25	790	93
26	739	130
27	758	169
28	768	212
29	1082	218
30	1017	154
Total	**15063**	**2758**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

El área de estadística en salud de la CCSS reporta al 4 de agosto 6 personas hospitalizadas por dengue: dos en el Hospital Max Peralta, uno en el Hospital San Rafael de Alajuela, uno en el Hospital San Juan de Dios, uno en el Hospital Enrique Baltodano y uno en el Hospital de San Carlos.

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 30

Rodrigo Marín Rodríguez
Programa de Control de Vectores
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

Rose Mary Hidalgo Ríos
Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM)

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la Semana Epidemiológica 30 del 2025, por el personal de Control de Vectores del país.

Cuadro 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la Semana Epidemiológica 30

	Total
Viviendas visitadas	**6.113**
Viviendas positivas	**342**
Depósitos tratados	**32.888**
Depósitos eliminados	**9.143**
Depósitos positivos	**523**
Viviendas fumigadas	**14.026**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Así mismo se detalla lo que llevamos de la Semana Epidemiológica 1 a la 30.

	Total
Viviendas visitadas	**362.661**
Viviendas positivas	**16.594**
Depósitos tratados	**1.356.075**
Depósitos eliminados	**931.060**
Depósitos positivos	**28.527**
Viviendas fumigadas	**360.530**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Sarah Arce Bonilla
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes

Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria, junto con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la **Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)** es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

El objetivo principal para este año es mantener la reducción sostenida de casos de malaria y avanzar hacia la meta de eliminación. Costa Rica se perfila como el próximo país de la región en obtener la certificación de cero casos autóctonos de malaria.

Como parte de las acciones se está priorizando el **fortalecimiento de la red de colaboradores voluntarios** en comunidades con barreras de acceso a los servicios de salud y esfuerzos para acerca el diagnóstico y tratamiento a personas en condición de movilidad humana que llevan su paso por el país.

II. Vigilancia epidemiológica

Situación de la malaria en Costa Rica: actualización a la semana epidemiológica 30 del 2025

El histórico de transmisión local de malaria en Costa Rica evidencia una tendencia sostenida a la disminución de casos en los últimos tres años. Durante el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 a 30:

- En **2023**, se notificaron **371 casos autóctonos**.
- En **2024**, se registraron **160 casos**, lo que representa una disminución del **57 %** respecto al mismo periodo del año anterior.
- En lo que va del año **2025**, se han reportado **7 casos autóctonos**, lo que representa una **reducción del 98 %** en comparación con el mismo periodo del 2023.

Esta tendencia positiva refleja el impacto de las intervenciones dirigidas a la interrupción de la transmisión local, especialmente en los focos históricos.

Distribución de casos de malaria por región de salud y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2025 (corte a la semana epidemiológica 30)

Durante el año 2025 se notificaron **41 casos de malaria** en el país. La distribución según clasificación epidemiológica y región de salud fue la siguiente:

- **6 casos autóctonos de *Plasmodium falciparum***, todos localizados en el foco de Matina en la Región Huetar Caribe.
- **1 caso autóctono de *P. vivax,*** en el foco de crucitas en la Región Huetar Norte.
- **29 casos importados** (22 por *P. vivax,* 6 por *P. falciparum* y 1 por *P. malariae*), con mayor concentración en las regiones Huetar Norte (17 casos de *P. vivax*). Las Distritos donde a nivel nacional donde se han captado casos importados se destacan: Cutris, Los Chiles, Osa, Carrandí, Cóbano, Pocosol, Hospital, Pavas, San Ramón, Tamarindo.
- **1 caso introducido** de *P. vivax* en la región Huetar Norte.
- **4 casos en estudio** (2 por *P. falciparum* y 2 por *P. vivax*).

Las personas afectadas en 2025 se desempeñan principalmente como **operarios de construcción, peones agrícolas, coligalleros** y personas en **condición de movilidad humana**, provenientes de **Nicaragua**, de la **ruta migratoria desde América del Sur**, o en retorno desde **México** y **Gabón (África)**.
Esta información resalta la importancia de mantener la vigilancia activa, fortalecer los mecanismos de respuesta en zonas de riesgo y asegurar el diagnóstico y tratamiento oportuno, con enfoque especial en poblaciones móviles y zonas de tránsito.

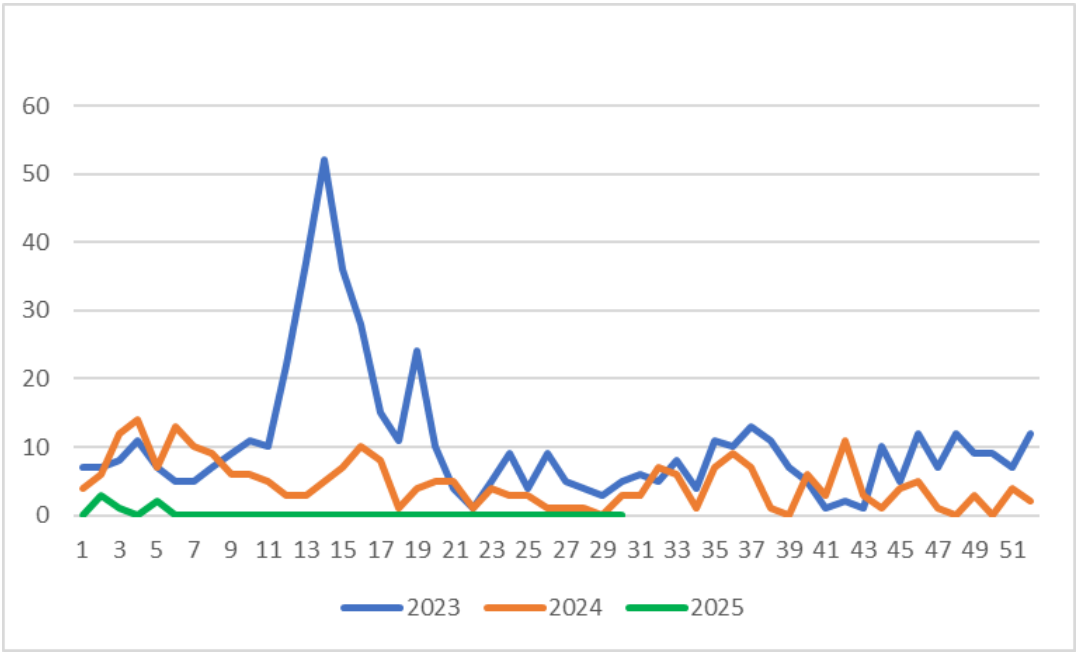
Tabla 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025.

Histórico Transmisión local			
Semana Epidemiológica	2023	2024	2025
1	7	4	0
2	7	6	3
3	8	12	1
4	11	14	0
5	7	7	2
6	5	13	0
7	5	10	0
8	7	9	0
9	9	6	0
10	11	6	0
11	10	5	0
12	22	3	0
13	37	3	0
14	52	5	0
15	36	5	0
16	28	7	0
17	15	8	0
18	11	1	0
19	24	4	0
20	10	5	0
21	4	5	0
22	1	1	0

23	5	4	1
24	9	3	0
25	4	3	0
26	9	1	0
27	5	1	0
28	4	1	0
29	3	0	0
30	5	3	0
Total	**371**	**160**	**7**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 30.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Producción de pruebas de diagnóstico.

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos.
A semana epidemiológica 30, se registraron 78.070 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por el Ministerio de Salud**: 35.075 referirse a la tabla 2.
    - **Colaboradores Voluntarios**: 822
    - **Inspectores de Salud**: 38.987

- **Pruebas de diagnóstico realizadas por CCSS**: 42.995, referirse al gráfico 3.
    - **Gotas gruesas**: 7.268
    - **Pruebas de diagnóstico rápido**: 35.370
    - **PCR**: 357

Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.

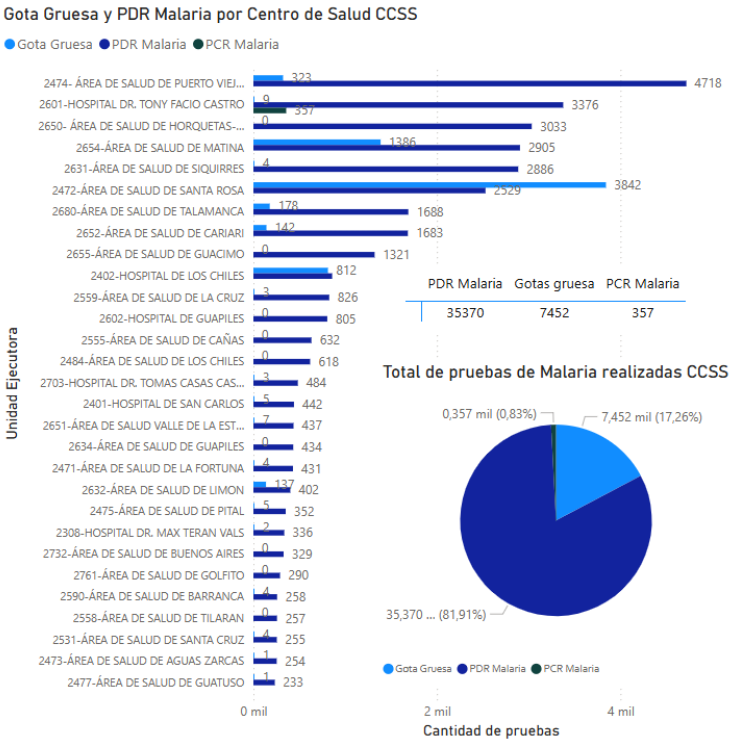
Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para cuantificar la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva.

Tabla 2.
Costa Rica: Vigilancia generada por inspectores de salud y voluntarios.

Región	Pruebas realizadas por Inspectores de Salud	Pruebas realizadas por voluntarios
Brunca	14982	56
Central Norte	356	28
Chorotega	4628	137
Huetar Caribe	8054	233
Huetar Norte	9439	331
Pacífico Central	1526	37
Total	38987	822

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 3.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS.



Fuente: CCSS.

Tabla 2.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS por región.

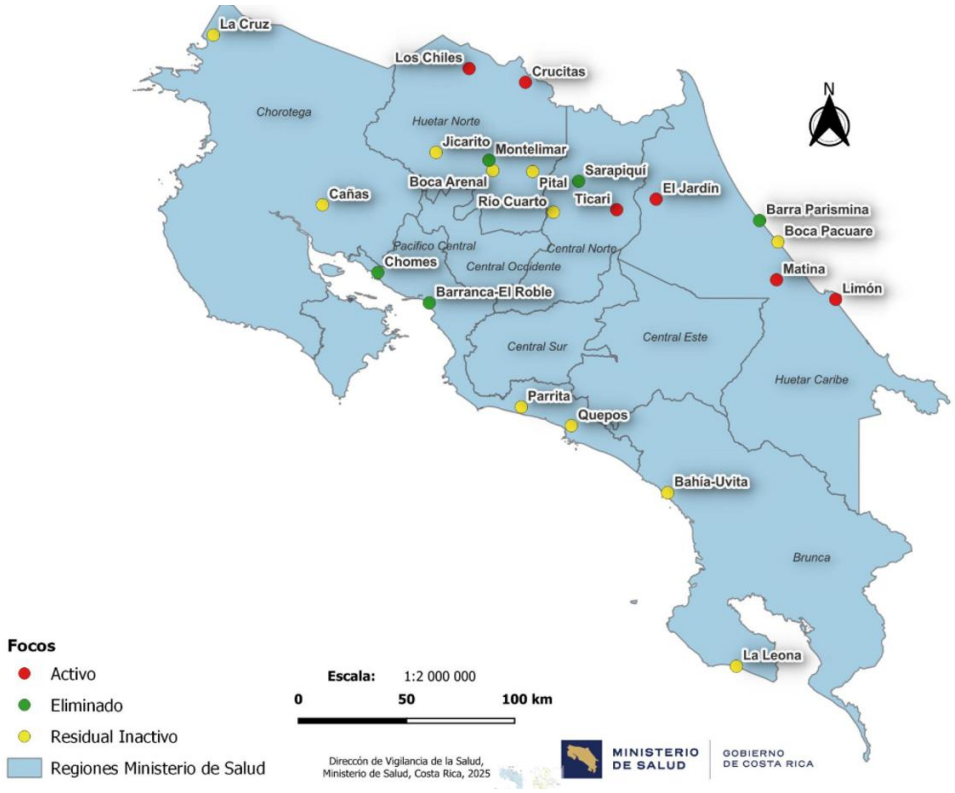
Dirección Regional a la que pertenece	Gotas Gruesas	PDR Malaria	PCR Malaria
Región Huetar Atlántica	1863	15939	357
Región Central Norte	357	7779	
Región Huetar Norte	4670	5881	
Región Chorotega	97	2468	
Región Brunca	33	1857	
Región Pacífico Central	177	1217	
Hospitales Nacionales o Especializados	217	206	
Región Central Sur	38	23	
Total	**7452**	**35370**	**357**

Fuente: CCSS. El dato incluye las Gotas gruesas de seguimiento.

III. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 6 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 5 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a mayo 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

IV. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 3.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a Enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Río Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

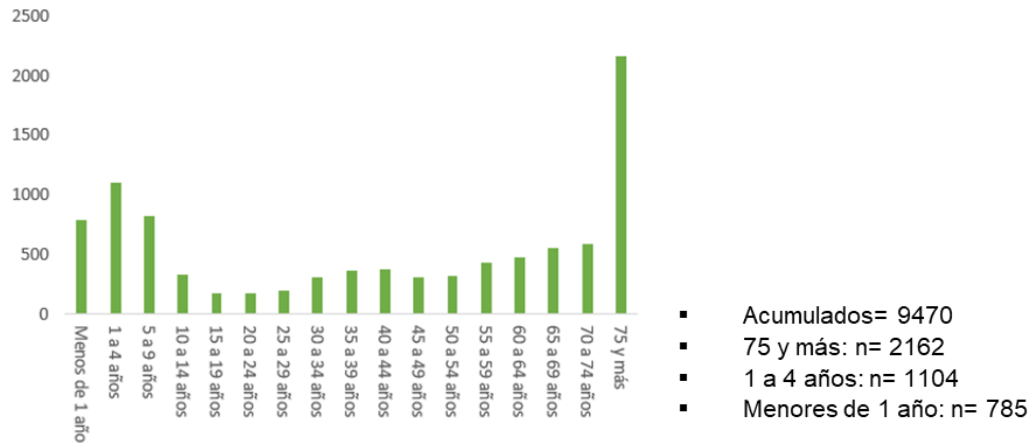
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 30 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 30 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 30 son un total de 9470.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

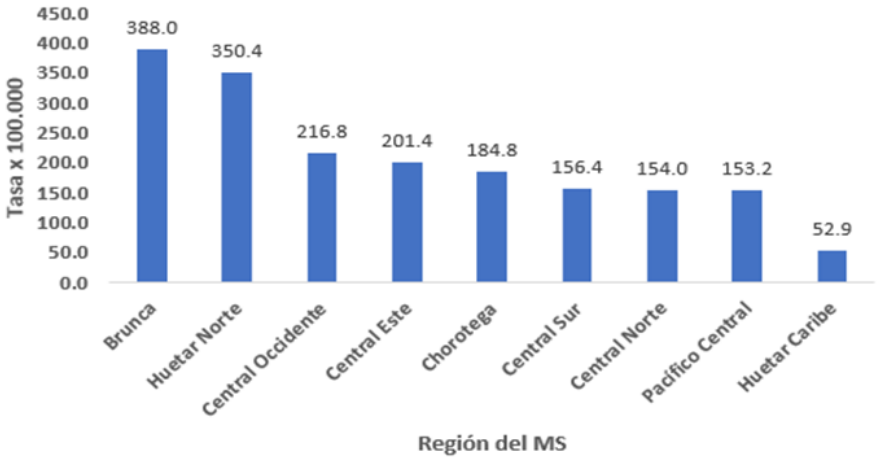
Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 30, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).
En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 30, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Brunca y la Huetar Norte; las regiones con menor incidencia corresponden a la Chorotega, Central Este, Central Occidente, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe.

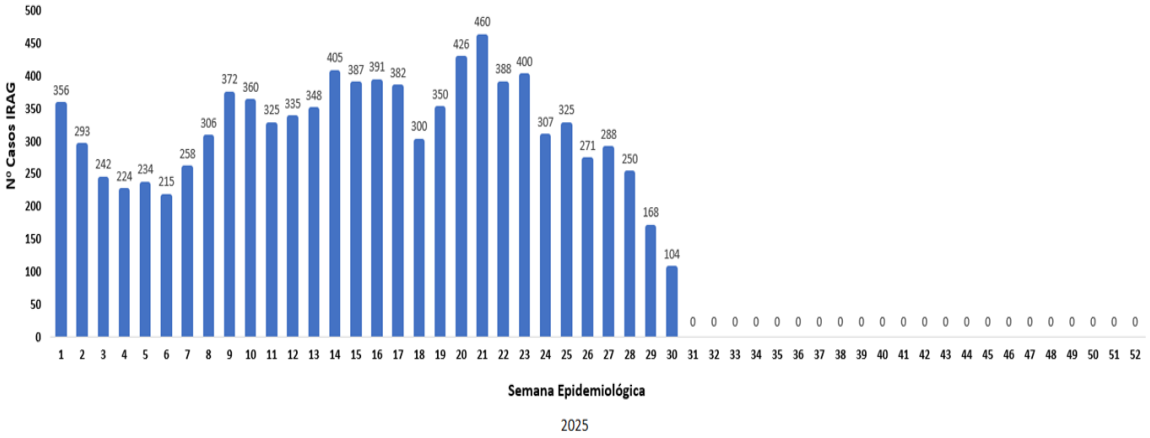
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 30 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

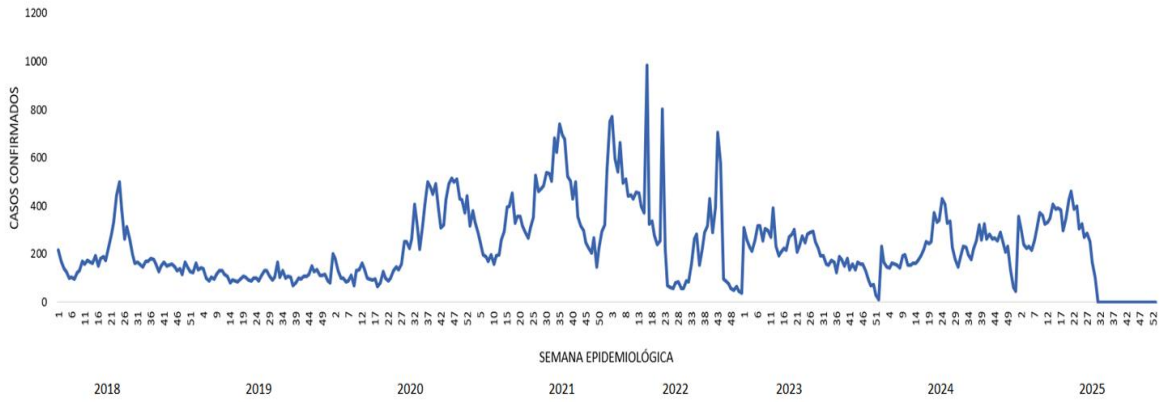
Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 30 del año 2025.

Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 30, en Costa Rica, 2025.


Nº Casos IRAG
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
356
293
242
224
234
215
258
306
372
360
325
335
348
405
387
391
382
300
350
426
460
388
400
307
325
271
288
250
168
104
0 0 0

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

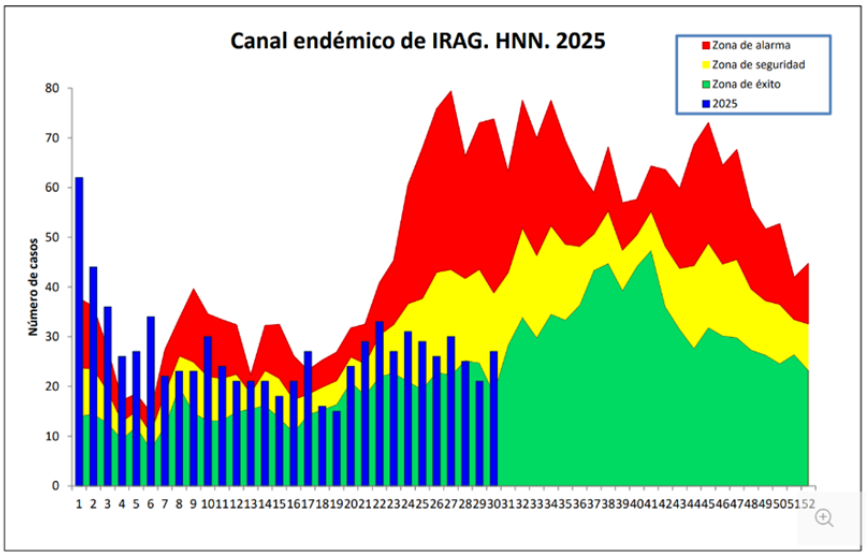
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-30 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra por en zona de seguridad, debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2025

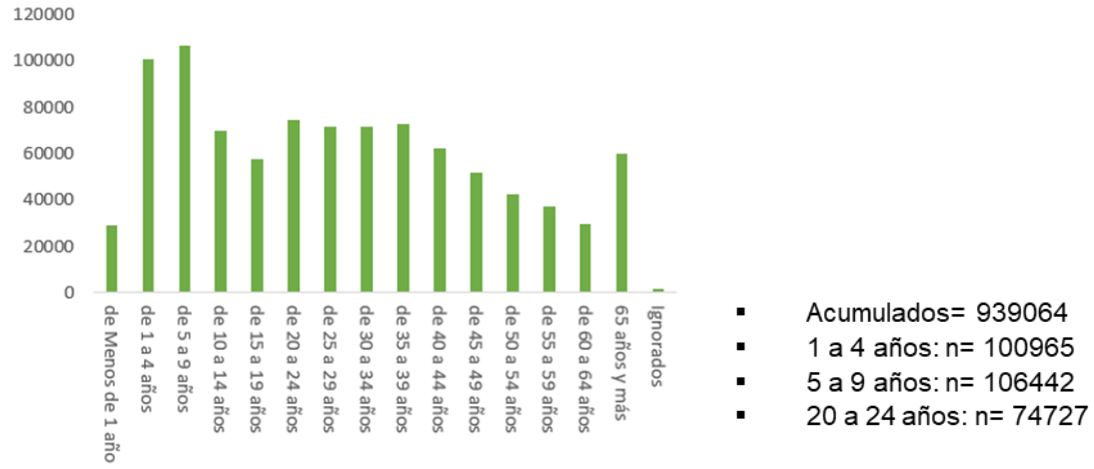


Fuente: EDUS-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 30 son 939064.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y menores entre 5 y 9 años.

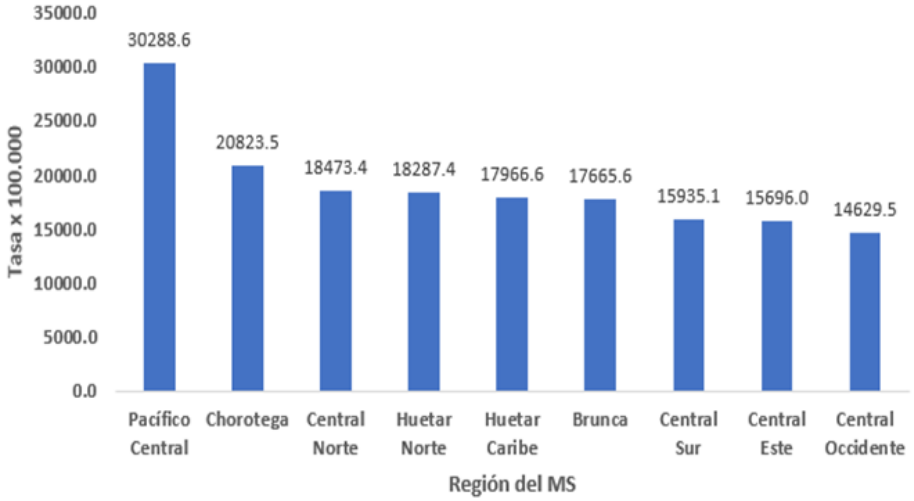
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 30, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 30, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central y Chorotega. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Central Norte, Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca, Central Occidente, Central Sur y Central Este.

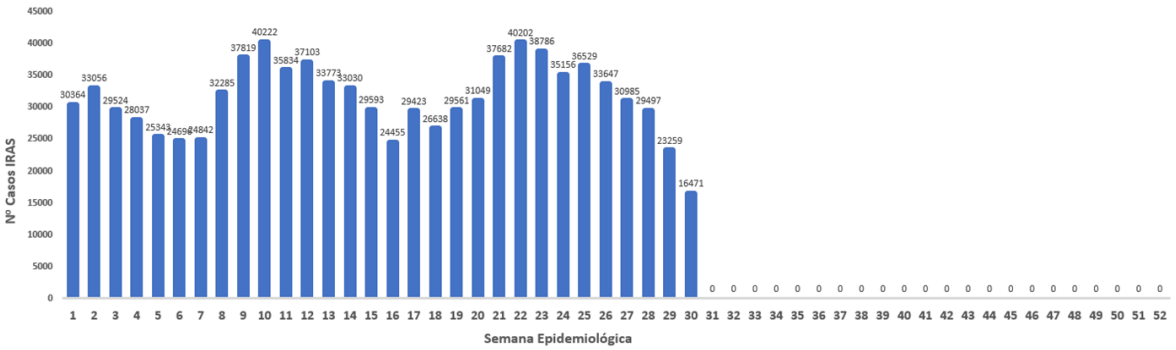
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 30 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 30 semanas epidemiológicas del año 2025.

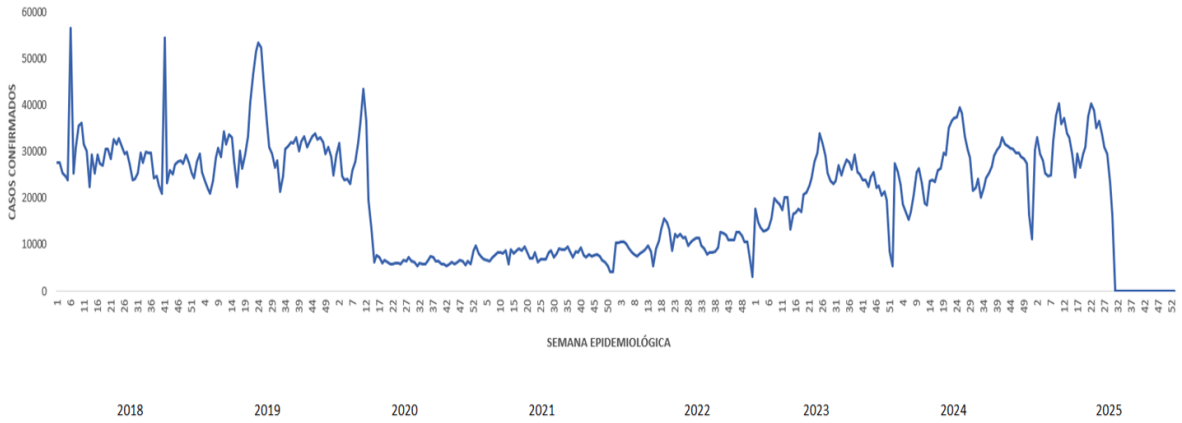
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 30, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

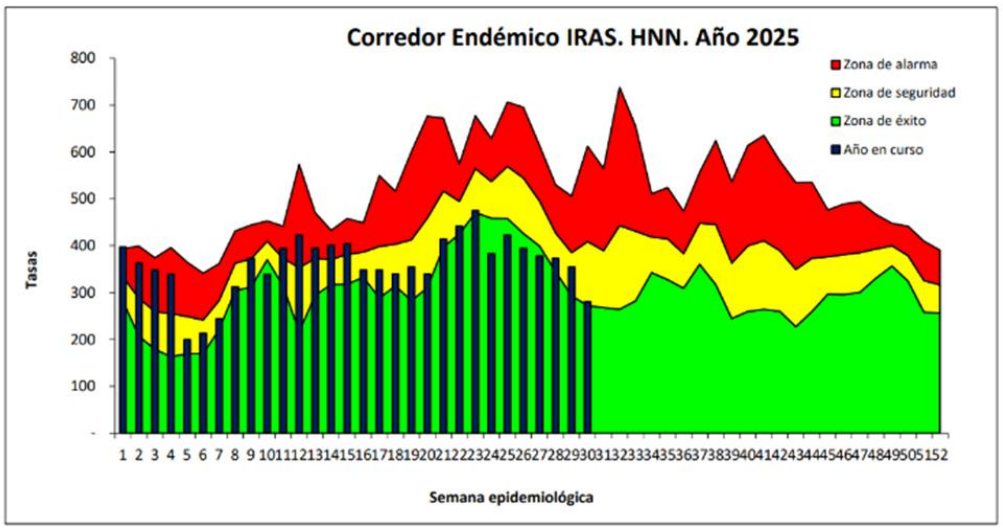
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 30 se encuentran en la zona de seguridad actualmente.

Gráfico 10.
Costa Rica: Canal endémico IRAS. HNN. 2025.

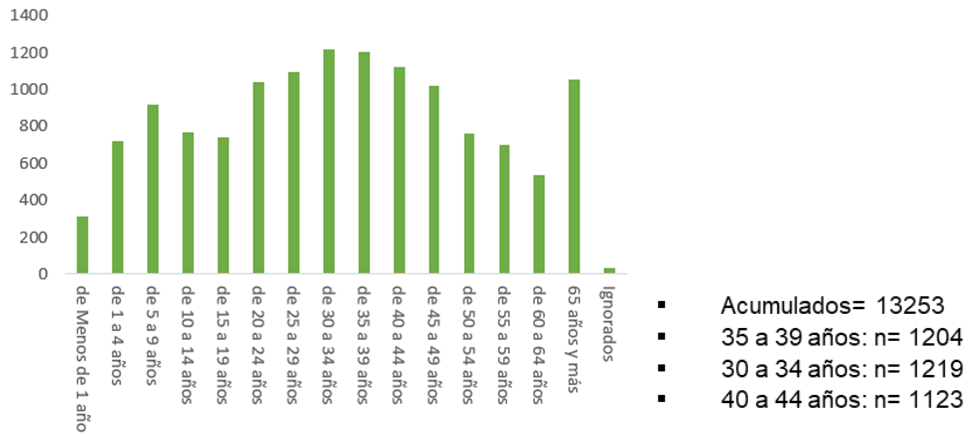


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 30 son n= 13253.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 35 y 39 años.

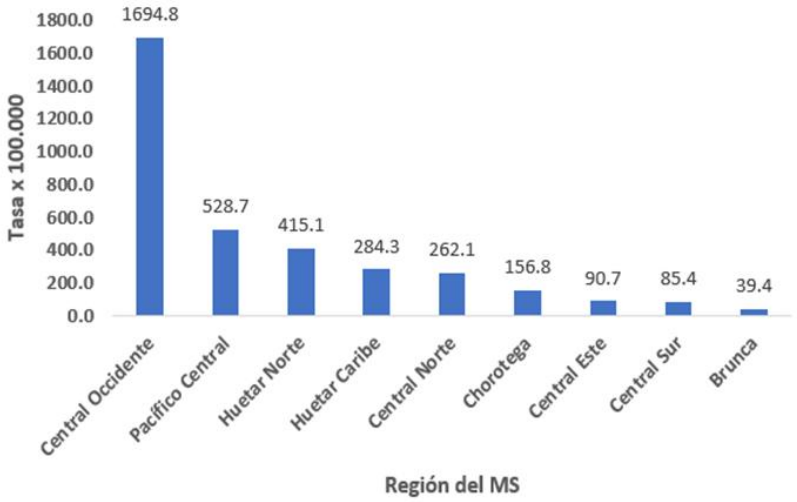
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 30, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 30, presentando mayor cantidad de casos en la región la Central Occidente. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Brunca, Chorotega, Central Este, Central Sur, Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte y Huetar Caribe.

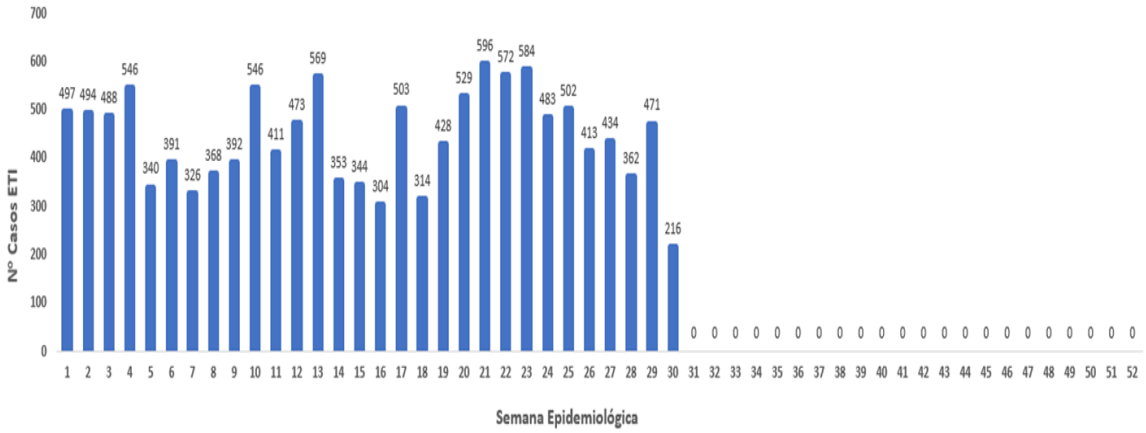
Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 30 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

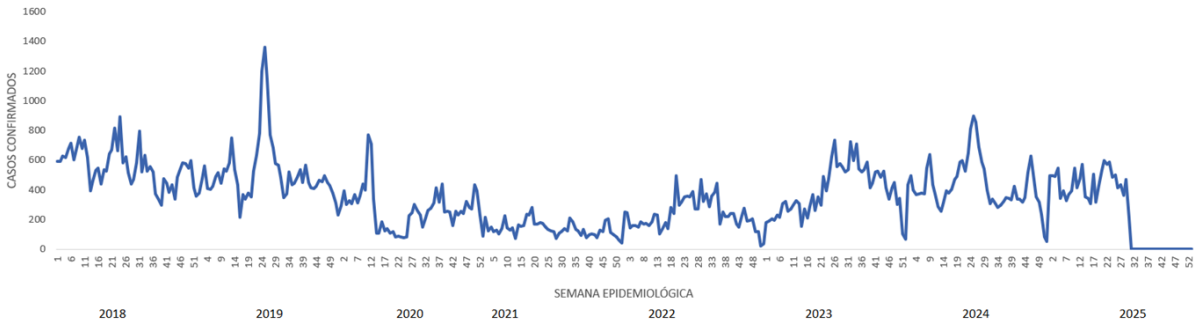
Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2025.

Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 30, en Costa Rica, 2025.


Nº Casos ETI
700
600
500
400
300
200
100
0
497 494 488 546 340 391 326 368 392 546 411 473 569 353 344 304 503 314 428 529 596 572 584 483 502 413 434 362 471 216
0 0 0

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

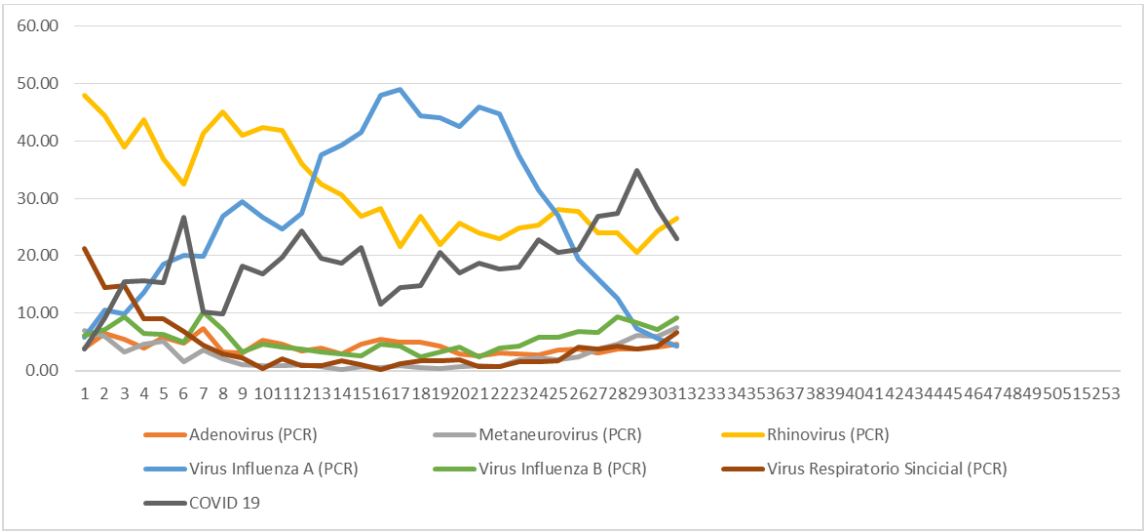
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 31; para la SE-31, en el país el Rinovirus es el que más está circulando, seguido del Covid-19 y finalmente el virus de la Parainfluenza está en tercer lugar de circulación.

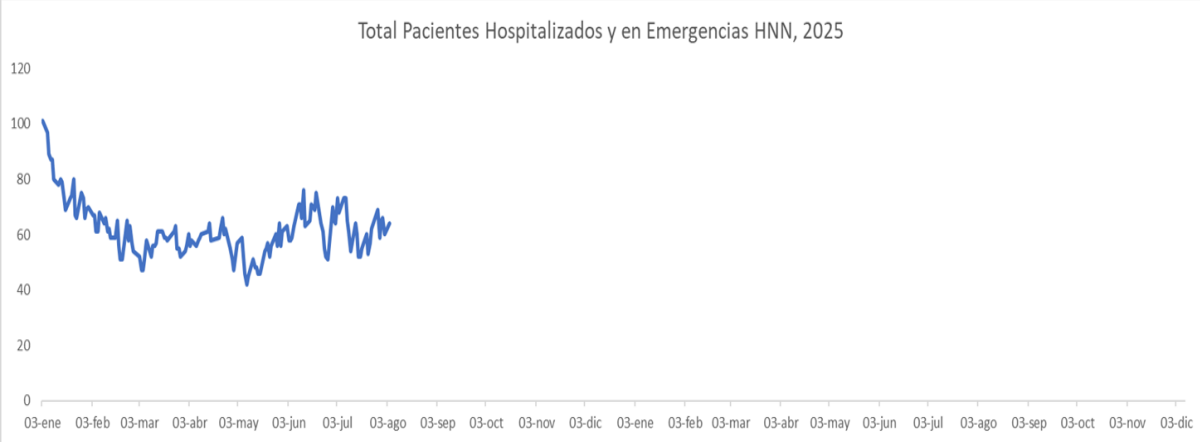
Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 31 en Costa Rica, 2025.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2025.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 31 del año 2025 es la siguiente:
Al 5 de agosto del año en curso, correspondiente a la semana 31, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 62, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 92.5%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 31 del año 2025, Hospital Nacional de Niños.



Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2025.

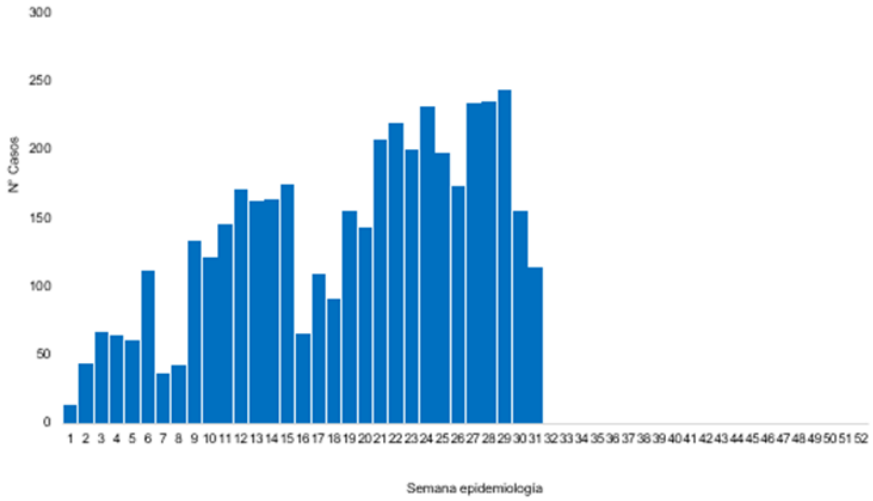
Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 9470 casos a la semana 30.
- IRAS con 939064 casos a la semana 30.
- ETI con 13253 casos reportados a la semana 30.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 92.5%
- En SE-31, el Rinovirus es el virus que más ha circulado, seguido del Covid-19 y en tercer lugar circula el Virus de Parainfluenza.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 31, se reportaron un total de 114 casos confirmados, lo que representa una disminución del 26.45% con respecto a la SE-30 del año 2025 que presentó 155 casos.

Gráfico 17.
Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2025.

SE	Casos
1	14
2	44
3	67
4	64
5	61
6	111
7	36
8	42
9	133
10	121
11	146
12	171
13	162
14	163
15	175
16	66
17	109
18	31
19	155
20	143
21	207
22	219
23	200
24	231
25	198
26	173
27	234
28	235
29	243
30	155
31	114

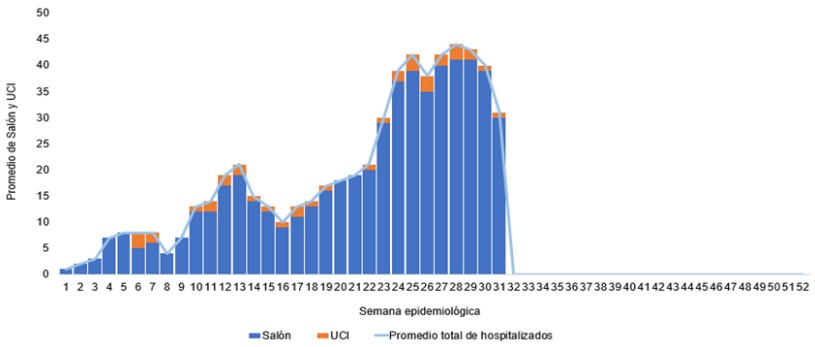


Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 31, se reportó un promedio total de 31 hospitalizados, lo que representa una disminución del 22.5% con respecto a la SE-30 del año 2025 donde se registraron 40 hospitalizaciones.

Gráfico 18.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2025.

SE	Salón	UCI	Promedio total de
1	1	0	1
2	2	0	2
3	3	0	3
4	7	0	7
5	8	0	8
6	5	3	8
7	6	2	8
8	4	0	4
9	7	0	7
10	12	1	13
11	12	2	14
12	17	2	19
13	19	2	21
14	14	1	15
15	12	1	13
16	9	1	10
17	11	2	13
18	13	1	14
19	16	1	17
20	18	0	18
21	19	0	19
22	20	1	21
23	29	1	30
24	37	2	39
25	39	3	42
26	35	3	38
27	40	2	42
28	41	3	44
29	41	2	43
30	39	1	40
31	30	1	31

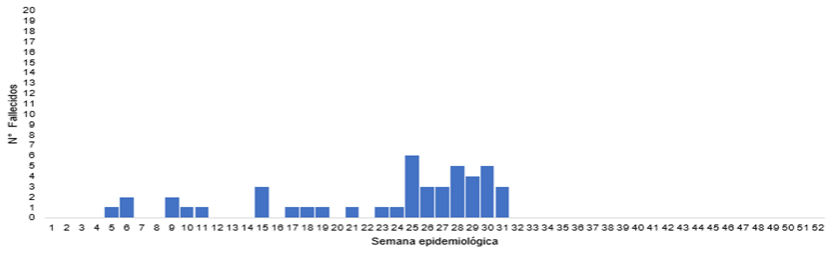


Fuente: Área de Estadística en Salud, CCSS/Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 31, hubo 3 fallecidos; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

Gráfico 19.
Costa Rica: Personas fallecidas asociadas a COVID-19, según reporte semanal año 2025.

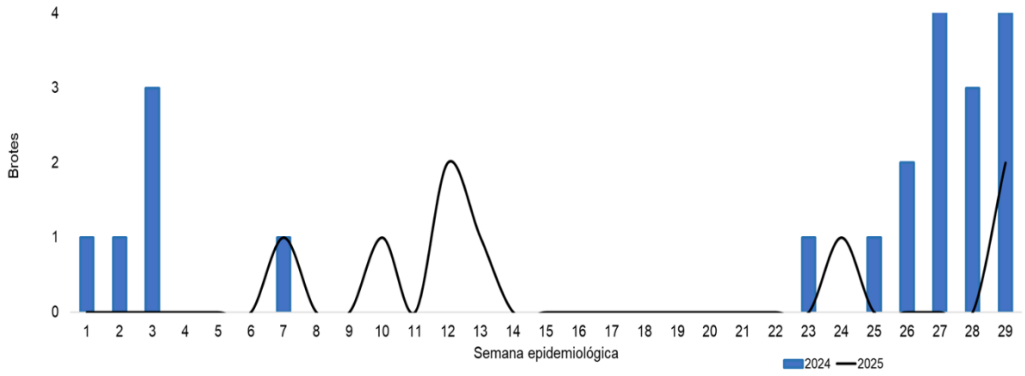
SE	Fallecidos
1	0
2	0
3	0
4	0
5	1
6	2
7	0
8	0
9	2
10	1
11	1
12	0
13	0
14	0
15	3
16	0
17	1
18	1
19	1
20	0
21	1
22	0
23	1
24	1
25	6
26	3
27	3
28	5
29	4
30	5
31	3



Fuente: Área de Estadística en Salud, C.C.S.S. / Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

Para la semana epidemiológica 29 se reportaron dos brotes asociados a COVID-19.

Gráfico 20.
Brotes de covid-19, por semana epidemiológica en Costa Rica, 2025.

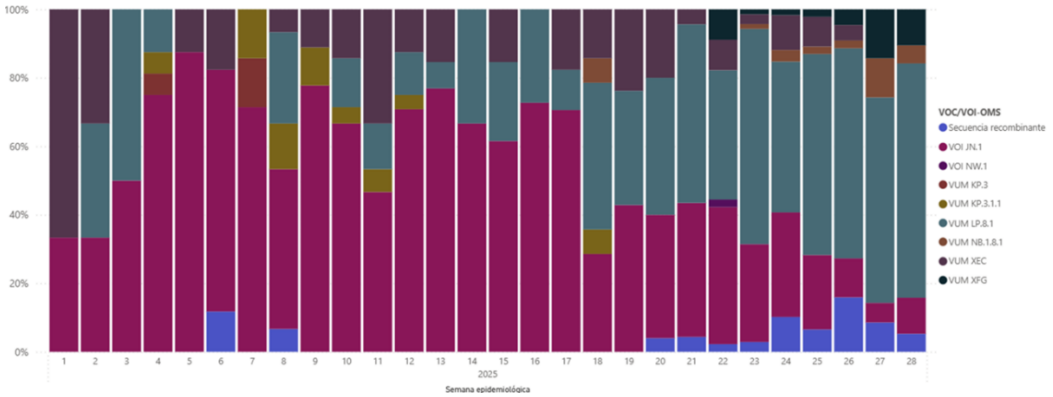


Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Nota: Se reportaron 24 brotes en el año 2024 y se han reportado 8 brotes en el año 2025

Variantes genómicas
Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 4 de agosto del 2025, se reporta lo siguiente.

Gráfico 21.
Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1-28 del 2025.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 4 de agosto del 2025.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido entre la SE-1 y la 28 del año 2025, se tiene la siguiente información.

Cuadro 1.
Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo de las semanas epidemiológicas 1-28 del 2025.

Linaje Pangolin	Cantidad	%
Secuencia recombinante	28	4.55
VOI JN.1	249	40.49
VOI NW.1	1	0.16
VUM KP.3	2	0.33
VUM KP.3.1.1	10	1.63
VUM LP.8.1	239	38.86
VUM NB.1.8.1	11	1.79
VUM XEC	59	9.59
VUM XFG	16	2.60
Total	615	100.00

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 5 de agosto 2025.

Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 4 de agosto de 2025.

Ivannia Caravaca Rodríguez.
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

En la semana epidemiológica 30 del año 2025 se reportan 248,469 casos acumulados de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). De acuerdo con el comportamiento epidemiológico de este evento, se observa una curva epidémica ubicada en zona de seguridad, con una tasa de incidencia de 4,786 casos por cada 100,000 habitantes, calculada con base en la actualización de datos poblacionales estimados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

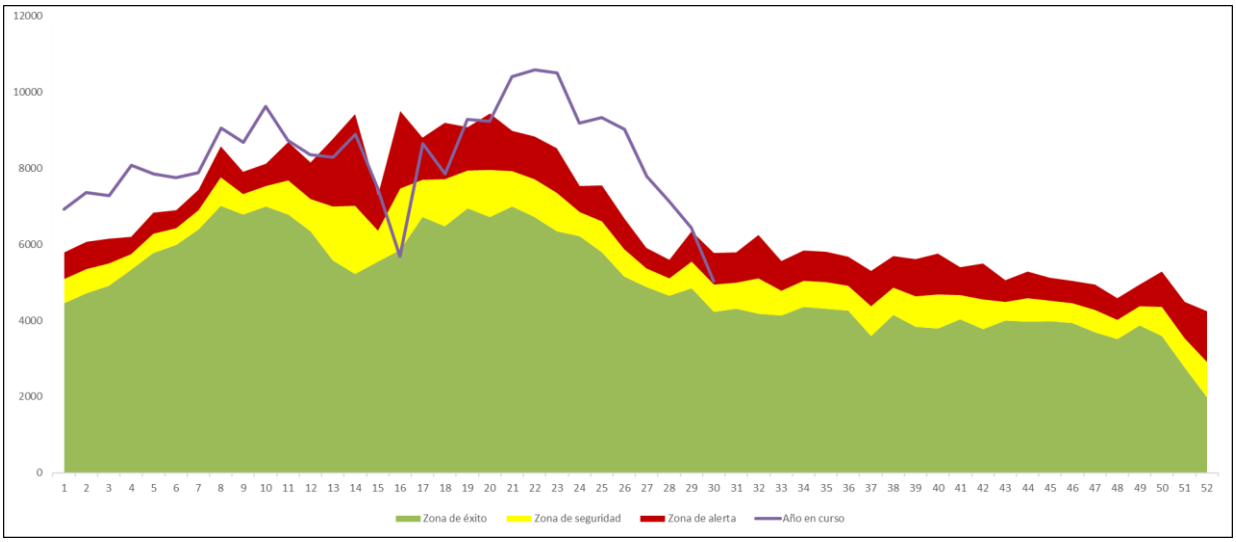
La incidencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) para la Semana Epidemiológica (SE) 30 del año 2025 refleja una disminución en los casos notificados respecto al mismo periodo del año 2023, lo que muestra una tendencia descendente sostenida a partir de la SE 20, comportamiento que contrasta con el aumento registrado en la misma etapa del 2023.

Durante las primeras 15 semanas del 2025, se observó una tendencia al alza respecto al 2023, con valores significativamente superiores, particularmente entre la SE 8 y SE 14, donde se alcanzaron picos como los 9,603 casos en la SE 10 (vs 6,602 en 2023). No obstante, a partir de la SE 16, esta tendencia comienza a revertirse progresivamente, y para la SE 30 se consolida una predisposición disminuida en la frecuencia de casos.

Este patrón refleja una situación epidémica ubicada en zona de alerta del canal endémico, lo cual coincide con la presencia del fenómeno climático de La Niña, asociado históricamente con un incremento en las lluvias y la humedad, condiciones que pueden favorecer la transmisión de agentes causantes de diarreas. Cabe destacar que en el 2023 se presentó una situación epidemiológica similar también bajo los efectos de La Niña.

Los datos presentados son preliminares y se encuentran en proceso de validación, por lo que podrían surgir ajustes que modifiquen la posición actual en el canal endémico.

Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 30. Años 2017- 2025. *

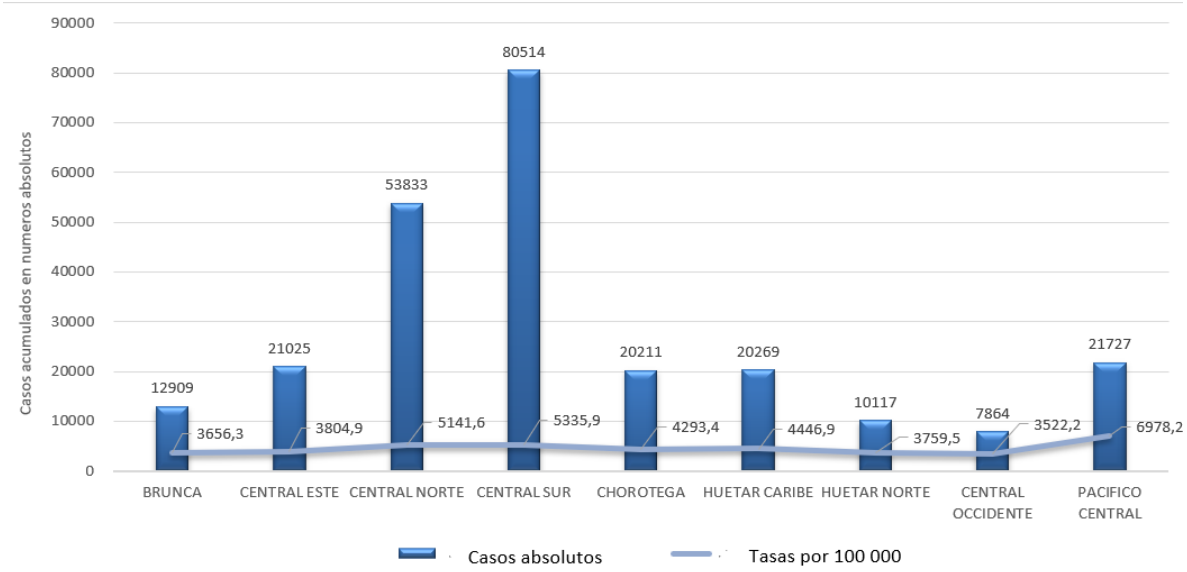


*Nota: Se excluyen del 2020 y 2021por la pandemia COVID-19 y 2023 por hackeo de la CCSS.
Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

El canal endémico para EDA muestra el comportamiento esperado de los casos en función de los datos históricos, clasificado en zonas de éxito (verde), seguridad (amarillo), alerta (rojo) y la línea morada correspondiente al año 2025.
Durante las primeras semanas epidemiológicas (SE 1–7), los casos se mantuvieron ligeramente por encima de la zona de éxito, oscilando entre la zona de seguridad y los límites inferiores de la zona de alerta. A partir de la SE 8, se presenta un ascenso más marcado, con inclusión constante dentro de la zona de alerta entre las semanas 8 y 14, superando incluso los picos máximos del canal histórico en semanas puntuales como la SE 10 y 13.
El punto más alto del año ocurre alrededor de la SE 14 a 15, seguido de una caída abrupta, pero que no logra sostenerse por debajo de la zona de alerta. Desde la SE 16 hasta la SE 23, los casos se estabilizan dentro o cerca del límite superior de la zona de alerta, reflejando un periodo de persistencia epidémica sostenida. En la SE 24 en adelante, se observa una disminución progresiva con oscilaciones hacia la zona de seguridad y posteriormente hacia la zona de éxito a partir de la SE 27–30, lo que indica un descenso epidemiológico favorable, la tendencia descendente observada en las últimas semanas sugiere que las medidas de control podrían estar teniendo efecto, aunque aún se debe mantener vigilancia activa, especialmente si se mantienen condiciones lluviosas o de riesgo sanitario.

A la Semana Epidemiológica 30 del 2025, los 15 cantones con las tasas de incidencia más elevadas de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) son: Flores, Vázquez de Coronado, Orotina, Puntarenas, Montes de Oro, Santa Cruz, Garabito, Matina, Mora, San Rafael, Goicoechea, Alajuela, Alajuelita y Nandayure. Estos cantones presentan una incidencia significativamente superior al promedio nacional, destacándose por mantener tasas elevadas de manera sostenida a lo largo del primer semestre del año, lo que sugiere una persistencia del riesgo epidemiológico en estos territorios, o una mejor notificación de estos eventos en los servicios de salud.
Las Regiones Rectoras con más casos son: Pacifico Central, Central Norte, Central Sur. El grupo de edad más afectado es el de adultos de 20 a 39 años.

Gráfico 2
Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según región del Ministerio de Salud. SE 30, 2025.



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Este comportamiento regional resalta la necesidad de enfocar acciones de prevención y control en las zonas con mayor incidencia relativa y carga acumulada, particularmente en las regiones Central Sur, Central Norte y Pacífico Central.

Se recomienda reforzar las campañas de educación dirigidas a la población, enfatizando el cumplimiento del protocolo de lavado de manos, así como la promoción de adecuadas prácticas de higiene personal, manipulación segura de alimentos y correcta cocción de estos. Estas medidas resultan fundamentales ante el incremento sostenido en los casos de diarrea aguda reportados por el sistema de salud, tanto de origen viral como bacteriano, los cuales superan el comportamiento esperado para esta época del año.

En este contexto, cobra especial relevancia la aplicación rigurosa del Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, el cual orienta las acciones necesarias para la investigación oportuna de los casos y brotes, incluyendo el uso de flujogramas para abordar distintas etiologías probables. Retomar con prioridad las actividades de vigilancia activa, investigación de campo y respuesta inmediata ante alertas locales es clave para contener la transmisión, identificar factores de riesgo y reducir la carga de enfermedad en las comunidades más afectadas.

.

Meningitis

Franchina Murillo Picado
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Paola Pérez Espinoza
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

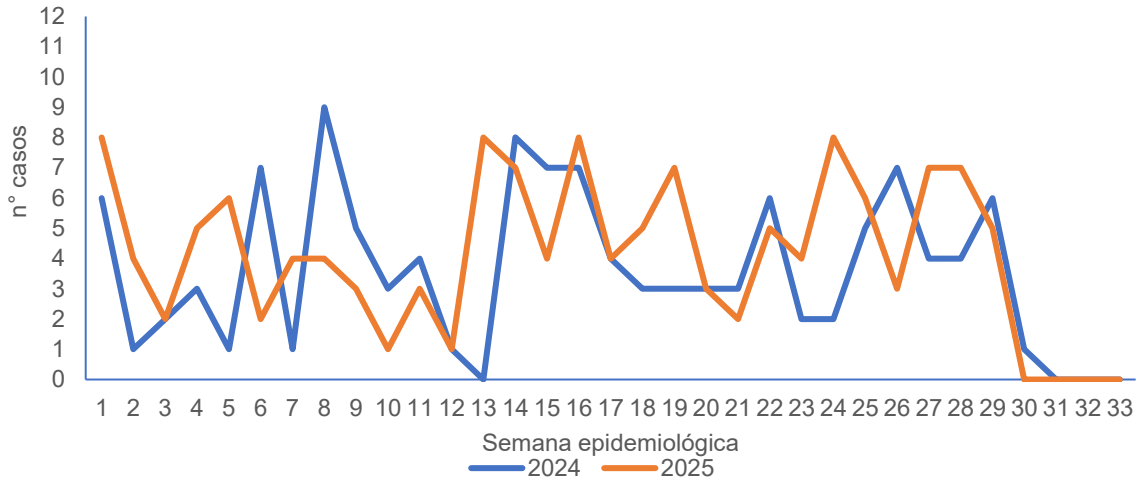
La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica.

La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250,000 muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Ocasiona la muerte de una de cada diez personas infectadas, en su mayoría niños y jóvenes y deja a una de cada cinco con discapacidades duraderas, como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.

En Costa Rica, hasta la semana epidemiológica 30 del año 2025, se han registrado 136 casos sospechosos de meningitis reportados mediante boleta VE01, lo que representa una tasa de incidencia de 2,5 por cada 100.000 habitantes. En comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 118 casos, se observa un incremento del 15,52% sin que se reporten brotes para esta semana.

De las 9 Regiones del Ministerio de Salud, la Región Central Sur es la que tiene la mayor cantidad de casos con un 23,5% (32/136) seguido de la Región Central Este y la Central Norte con el 22,8% (31/136) respectivamente.

Figura 1.
Costa Rica: Casos sospechosos de meningitis comparativa año 2024 con el 2025 a la semana epidemiológica 30, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

En la siguiente tabla se enlista los cantones con las tasas más altas de meningitis. Turrubares de la provincia de San José es el que tiene la tasa más alta de 13,1, seguido de Dota también de la provincia de San José con 12,2 y Cartago con 10,1.

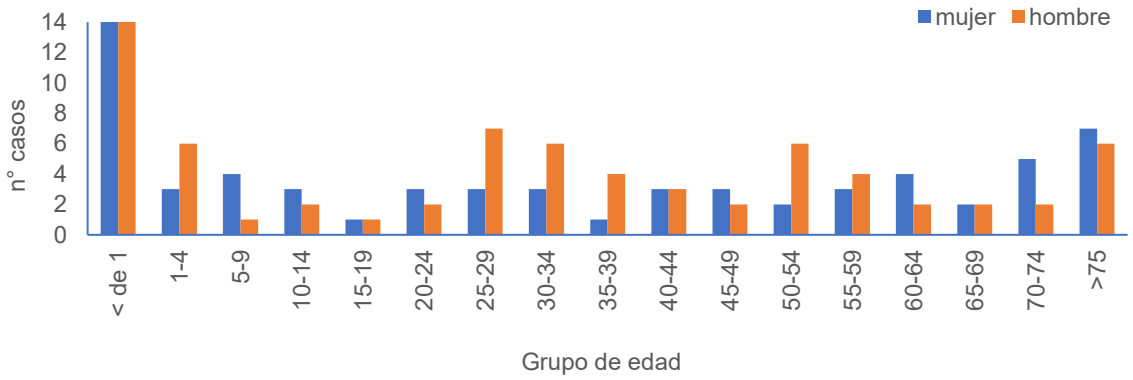
Figura 2.
Costa Rica: Casos notificados de meningitis según cantón, acumulado a la semana epidemiológica 30, 2025 (tasa p/100.000 habitantes).

cantón	casos	tasa
Turrubares	1	13,8
Dota	1	12,2
Cartago	17	10,1
Osa	3	9,5
Cañas	3	8,7
Santa Cruz	6	8,0
Bagaces	2	7,7
Sarapiqui	7	7,4
Leon Cortes	1	7,0
Alvarado	1	6,3
Jimenez	1	6,1
Liberia	5	6,0
Quepos	2	5,7
Tarrazu	1	5,2
San Rafael	3	5,1
Perez Zeledon	7	4,9
Santa Barbara	2	4,4
Valverde Vega	1	4,3
Talamanca	2	4,2
Turrialba	3	4,1
Flores	1	3,8
La Union	4	3,4
Alajuela	11	3,3
Montes de Oca	2	3,2
Moravia	2	3,1
San Pablo	1	3,1
Aserri	2	3,0
Alajuelita	3	3,0
Goicoechea	4	2,8
Esparza	1	2,5
Desamparados	6	2,4
Palmares	1	2,3
Coto Brus	1	2,3
San Jose	8	2,2
El Guarco	1	2,1
Grecia	2	2,0
Naranjo	1	2,0
Barva	1	2,0
Santo Domingo	1	2,0
Limon	2	2,0
Nicoya	1	1,7
Guacimo	1	1,7
Santa Ana	1	1,6
Paraiso	1	1,5
Siquirres	1	1,5
Escazu	1	1,4
Heredia	2	1,3
Pococi	2	1,2
San Carlos	2	0,9
Total	**136**	**2,5**

Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

La figura 3, indica la distribución de los casos sospechosos según sexo y grupo de edad. El 47,7% de los casos (65/136) son mujeres y el 52,2% (71/136) son hombres. El 22,0% de los casos (30/136) son menores de 1 año.

Figura 3.
Costa Rica: Casos sospechosos por meningitis según sexo y edad, a la semana epidemiológica 30, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

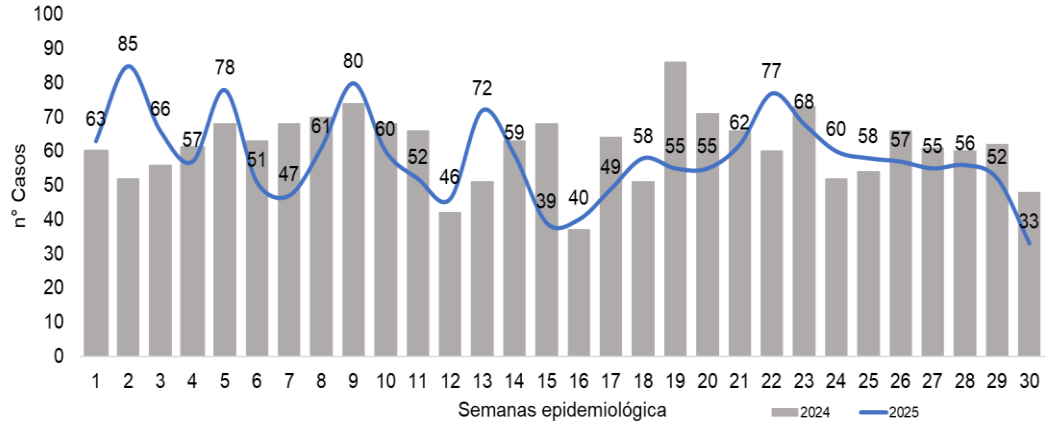
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son de notificación obligatoria, conforme al Reglamento de Vigilancia de la Salud N.º 40556-S. Por lo tanto, su vigilancia semanal constituye un componente esencial para la salud pública del país.

Durante las semanas 1 a la 30 del año 2025, se han reportado los siguientes tipos de ITS: sífilis en todas sus formas, gonorrea, infección por el virus del herpes simple (VHS) y virus del papiloma humano (VPH).

La sífilis en todas sus formas es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*. Es completamente prevenible mediante el uso adecuado del condón y cuenta con tratamiento efectivo. Esta infección se transmite principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, así como de madre a hijo durante el embarazo. Debido a su impacto en la salud materno-infantil y en la población general, la sífilis representa un factor importante en la morbilidad y mortalidad del país.

Durante las semanas 1 a 30 del año 2025, se han notificado 1.751 casos, lo que representa una tasa de 32,7 por cada 100.000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 1.841 casos, evidenciando una disminución del 4,88 % en 2025 equivalente a 90 casos menos. En el Gráfico 1 se presentan los datos distribuidos por semana epidemiológica según el reporte.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares, sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento epidemiológico de esta enfermedad durante las semanas 1 a 30 del año en curso, muestra que el 58,54 % de los casos (1.025 de 1.751) se registraron en hombres, con una tasa de 38,1 por cada 100.000 habitantes. En mujeres, se reportó el 41,46 % de los casos (726 de 1.751), con una tasa de 27,3 por cada 100.000 habitantes.

Los casos notificados se concentran principalmente en el grupo de edad de 20 a 64 años, que representa el 80,87 % (1.416 de 1.625 casos). Le siguen las personas mayores de 65 años con el 9,4 % (167 casos), el grupo de 15 a 19 años con el 4,7 % (82 casos), en los menores de 1 año con el 4,7 % (82 casos). En los grupos de 1 a 4 años con tres casos, el grupo de 5 a 9 años sin casos y el grupo de 10 a 14 años con un caso, ver cuadro 1.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos de sífilis en todas sus formas, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 30 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	82	121,4
de 1 a 4 años	3	1,1
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	1	0,3
de 15 a 19 años	82	21,6
de 20 a 24 años	220	56,6
de 25 a 29 años	266	62,6
de 30 a 34 años	262	59,0
de 35 a 39 años	199	44,0
de 40 a 44 años	142	34,8
de 45 a 49 años	117	33,7
de 50 a 54 años	76	25,9
de 55 a 59 años	64	23,0
de 60 a 64 años	70	26,7
de 65 a 69 años	54	25,3
de 70 a 74 años	42	27,0
75 años y más	71	33,7
Total	1751	32,70

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 2, se presenta el comportamiento de esta enfermedad, según provincias, siendo Limón la provincia con una mayor tasa de 56,7 por 100 000 habitantes.

Cuadro 2.
Costa Rica: Casos notificados de sífilis en todas sus formas según provincias de procedencia. Números absolutos. (Tasa p/100.000 habitantes), en semana 30 del 2025.

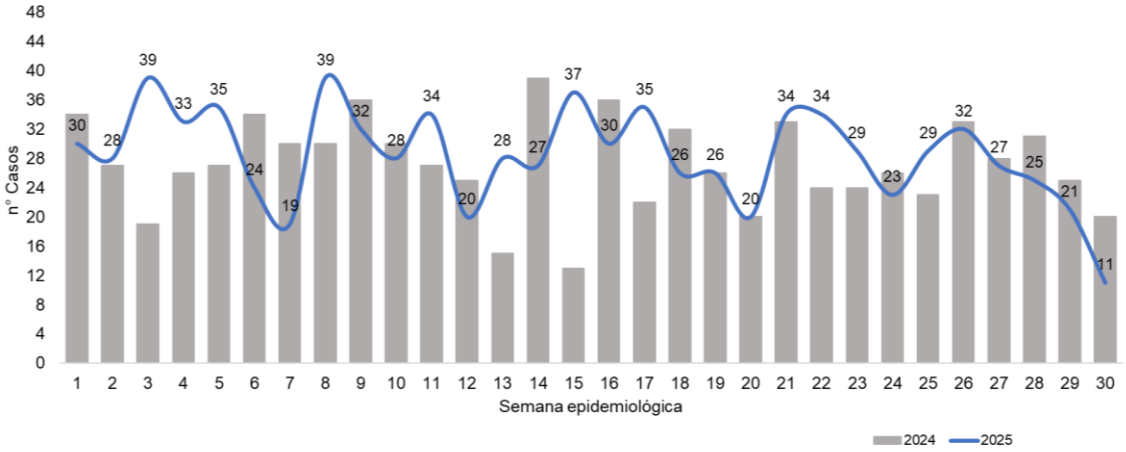
Provincias	Nº	Tasa
San José	614	35,8
Alajuela	280	25,6
Cartago	230	41,4
Heredia	137	24,5
Guanacaste	85	20,2
Puntarenas	131	24,8
Limón	274	56,7
Total	1751	32,70

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

La gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, es una enfermedad completamente prevenible mediante el uso correcto y consistente del condón, y además es tratable. Se transmite principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, así como de madre a hijo durante el parto. Debido a su impacto en la salud individual y pública, esta infección contribuye significativamente a la morbilidad del país.

Durante las semanas 1 a 30 del año 2025, se han notificado 855 casos, lo que representa una tasa de 16,0 por cada 100.000 habitantes. En el mismo periodo de 2024 se reportaron 815 casos, evidenciando un incremento del 4,9% en 2025, equivalente a 40 casos adicionales. En el gráfico 2 se presentan los datos distribuidos por semana epidemiológica, lo que permite visualizar la evolución temporal del comportamiento de la enfermedad.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Durante las semanas 1 a 30 del año 2025, el comportamiento de esta enfermedad muestra una marcada predominancia en hombres, quienes representan el 84,4% de los casos (722 de 855), con una tasa de incidencia de 26,8 por cada 100.000 habitantes. En contraste, las mujeres concentran el 15,56% de los casos (133 de 855), con una tasa de 5,0 por cada 100.000 habitantes. Esta distribución evidencia una diferencia significativa en la afectación por sexo.

La distribución de los casos notificados por grupos de edad durante las primeras 30 semanas del año 2025, muestra que el mayor porcentaje corresponde al grupo de 20 a 64 años, con un 82,2% (703 de 855 casos). Le sigue el grupo de 15 a 19 años con un 14,8% (127 casos), y los mayores de 65 años con un 2,0% (16 casos). Además, en los menores de 1 años se reportaron dos casos, en menores de 1 a 4 año tres casos en el grupo de 5 a 9 años un caso y el grupo de 10 a 14 años con tres casos. Esta información se detalla en el cuadro 3.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 30 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	2	3,0
1 a 4	3	1,1
5 a 9	1	0,3
10 a 14	3	0,8
15 a 19	127	33,5
20 a 24	212	54,5
25 a 29	165	38,8
30 a 34	123	27,7
35 a 39	82	18,1
40 a 44	47	11,5
45 a 49	18	5,2
50 a 54	26	8,9
55 a 59	21	7,5
60 a 64	9	3,4
65 a 69	10	4,7
70 a 74	3	1,9
Más 75 años	3	1,4
Total	855	16,00

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 4, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país. Siendo Limón la provincia con mayor tasa. En el siguiente cuadro se detalla más.

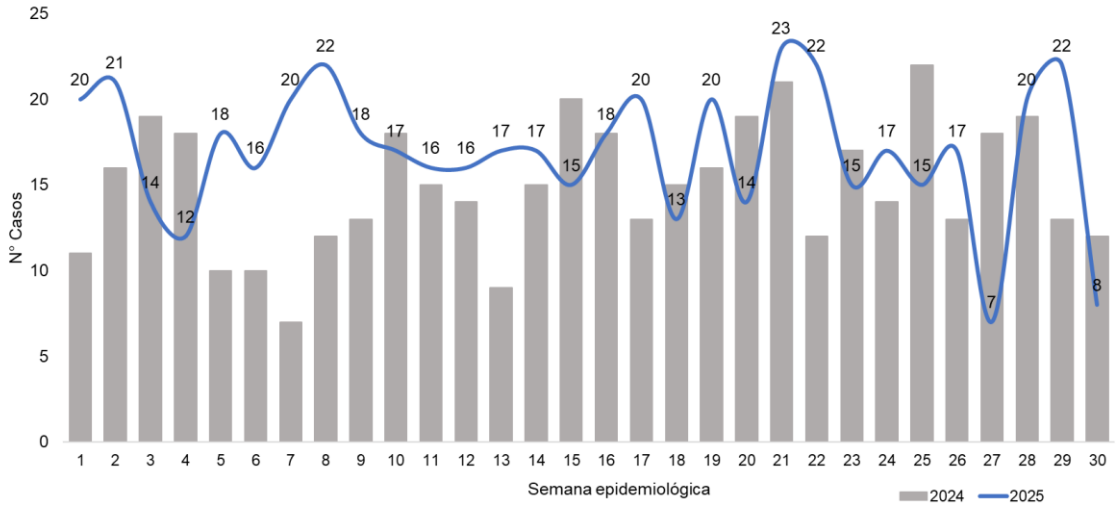
Cuadro 4
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 30 del 2025.

Provincias	Casos	Tasa
San José	310	18,1
Alajuela	132	12,1
Cartago	71	12,8
Heredia	75	13,4
Guanacaste	51	12,1
Puntarenas	95	18,0
Limón	121	25,0
Total	855	16,00

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El virus del herpes es otra infección de transmisión sexual que ha sido reportada durante las semanas 1 a 30 del año 2025, con un total de 510 casos, lo que representa una tasa de incidencia de 9,5 por cada 100.000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se registraron 449 casos, evidenciando un incremento del 14,0% en 2025, equivalente a 61 casos adicionales. En el gráfico 3 se presenta la evolución semanal de los casos reportados, lo que permite observar el comportamiento epidemiológico de esta infección.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos notificados por el virus del herpes, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

A lo largo de las primeras 30 semanas del año 2025, el comportamiento del virus del herpes muestra una mayor afectación en mujeres, quienes representan el 68,6% de los casos (350 de 510), con una tasa de 13,1 por cada 100.000 habitantes. En los hombres se reportó el 31,3% de los casos (169 de 510), con una tasa de 5,9 por cada 100.000 habitantes. Esta diferencia por sexo evidencia que las mujeres son las que más presentan está enfermedad.

La distribución de los casos notificados por grupos de edad durante las primeras 30 semanas del año 2025, se muestra que el grupo de 20 a 64 años concentra el mayor número de reportes, con un 82,1% (419 de 510 casos). Le sigue el grupo de 15 a 19 años con un 12,3% (63 casos), y los mayores de 65 años con un 4,1% (21 casos). Además, en menores de 1 año se reportan dos casos, en el grupo de 10 a 14 años dos casos y en los otros grupos no reportaron casos durante este periodo. Esta información se detalla en el cuadro 5.

Cuadro 5.
Costa Rica: Casos de virus del herpes, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 30 del 2025.

Grupos de edad	Caso	Tasa
Menos 1 año	2	3,0
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	5	1,3
15 a 19	63	16,6
20 a 24	96	24,7
25 a 29	79	18,6
30 a 34	70	15,8
35 a 39	61	13,5
40 a 44	35	8,6
45 a 49	31	8,9
50 a 54	11	3,7
55 a 59	19	6,8
60 a 64	17	6,5
65 a 69	13	6,1
70 a 74	6	3,9
Más 75 años	2	0,9
Total	510	9,50

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 6, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país. Siendo la provincia de San José con mayor tasa.

Cuadro 6
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes, según provincias. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 30 del 2025.

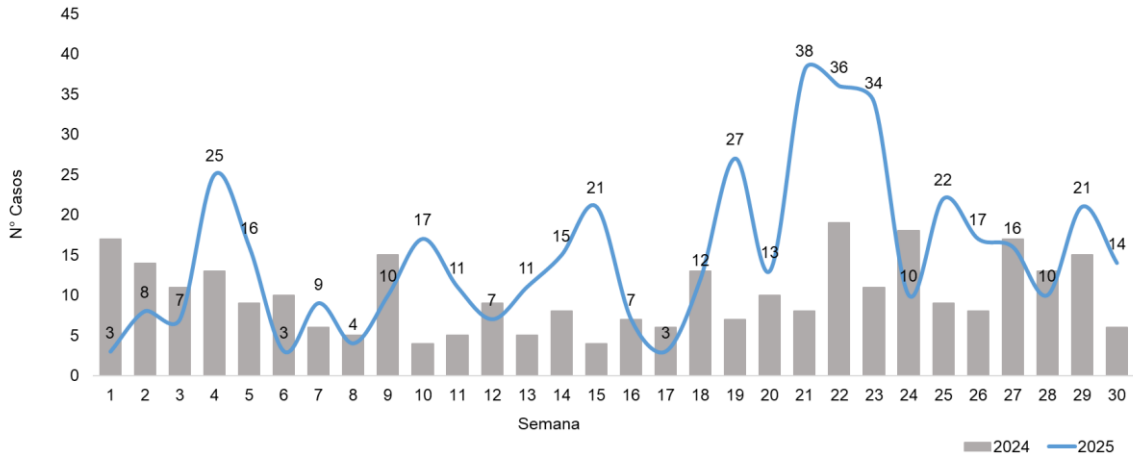
Provincias	Casos	Tasa
San José	244	14,2
Alajuela	57	5,2
Cartago	33	5,9
Heredia	35	6,3
Guanacaste	14	3,3
Puntarenas	63	11,9
Limón	64	13,2
Total	510	9,50

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El Virus del Papiloma Humano (VPH), es una infección de transmisión sexual que se transmite principalmente por contacto directo con la piel o mediante relaciones sexuales sin protección. Su prevención incluye el uso correcto del condón y evitar el contacto sexual cuando la pareja presenta síntomas visibles.

Durante las semanas 1 a 30 del año 2025, se notificaron 447 casos, lo que equivale a una tasa de 8,3 por cada 100.000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 302 casos, lo que representa un incremento del 48,0% en 2025, con 145 casos adicionales. La evolución semanal de los casos se presenta en el gráfico 4.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humano, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025.



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del Virus del Papiloma Humano (VPH), durante las primeras 30 semanas del año 2025, se muestra una marcada predominancia en mujeres, quienes representan el 92,0% de los casos (411 de 447), con una tasa de incidencia de 15,4 por cada 100.000 habitantes. En los hombres se notificó el 8,0% de los casos (36 de 447), con una tasa de 1,3 por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la distribución por grupos de edad, el mayor número de casos se concentra en el grupo de 20 a 64 años, con un 96,2% (430 de 447). Le sigue el grupo de 15 a 19 años con un 2,7% (12 casos), mientras que los mayores de 65 años reportaron tres casos. Además, los menores 1 año se notifican 2 casos. Los demás grupos de edad no reportaron casos durante este periodo. Esta información se detalla en el cuadro 7.

Cuadro 7.
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humanos, por grupos de edad. Número absoluto. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 30 del 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	2	3,0
de 1 a 4 años	0	0,0
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	0	0,0
de 15 a 19 años	12	3,2
de 20 a 24 años	28	7,2
de 25 a 29 años	25	5,9
de 30 a 34 años	83	18,7
de 35 a 39 años	91	20,1
de 40 a 44 años	55	13,5
de 45 a 49 años	48	13,8
de 50 a 54 años	26	8,9
de 55 a 59 años	46	16,5
de 60 a 64 años	28	10,7
de 65 a 69 años	3	1,4
de 70 a 74 años	0	0,0
75 años y más	0	0,0
Total	447	8,30

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 8, se presenta la notificación del VPH, según provincia. Siendo Puntarenas la provincia con mayor tasa.

Cuadro 8.
Costa Rica: Casos notificados por virus del papiloma humano, según provincia. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 30 del 2025.

Provincias	Nº	Tasa
San José	103	6,0
Alajuela	38	3,5
Cartago	15	2,7
Heredia	7	1,3
Guanacaste	115	27,4
Puntarenas	165	31,3
Limón	4	0,8
Total	447	8,30

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Miasis por gusano barrenador en humanos

María José Lafuente González
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

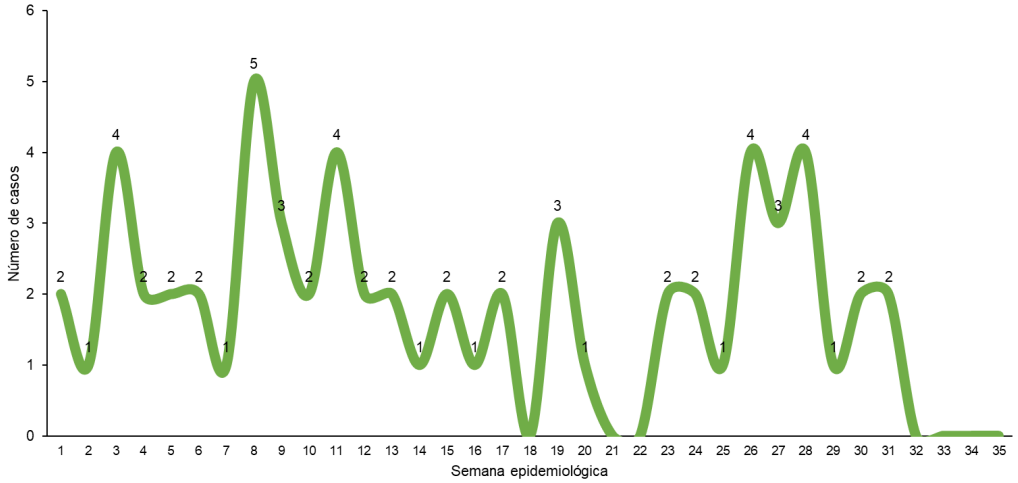
Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica (SE) 31 del año 2025, según establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2025 a la SE 31, se tienen los siguientes datos:

- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 63 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (28/63) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (31/63).

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 31, 2025.



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

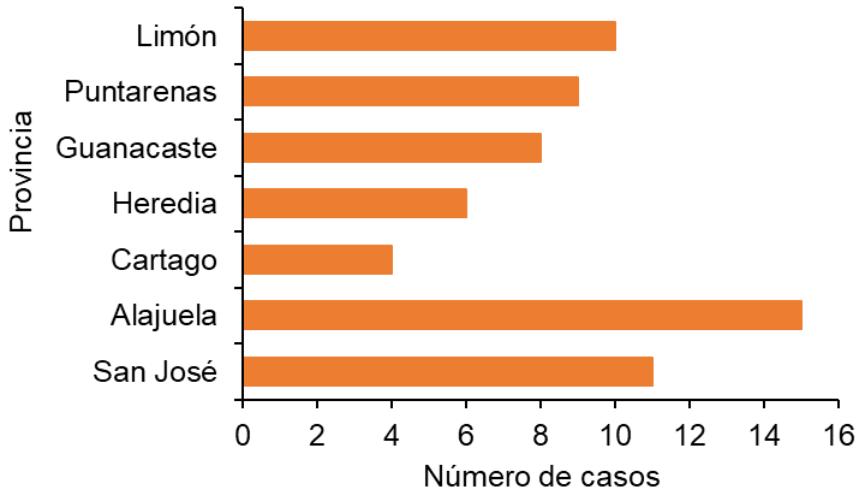
Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasa (tasa p/100.000 habitantes) según grupo de edad, de la SE 01 a la 31, 2025.

Grupos de edad	Casos	Tasa
TOTAL	**63**	**1,2**
< 1	0	0,0
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	3	0,8
15 a 19	1	0,3
20 a 24	3	0,8
25 a 29	4	0,9
30 a 34	1	0,2
35 a 39	1	0,2
40 a 44	3	0,7
45 a 49	5	1,4
50 a 54	1	0,3
55 a 59	3	1,1
60 a 64	7	2,7
65 a 69	7	3,3
70 a 74	5	3,2
≥75	19	9,0

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2025, presenta un predominio en los hombres con 42 casos notificados con una tasa de 1,6 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 21 casos notificados con una tasa de 0,8 por 100.000 habitantes.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según provincia de procedencia, de la SE 01 a 31, 2025.



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 2, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por número de casos notificados a la SE 31 según provincia de procedencia, presentando mayor número de casos la provincia de Alajuela (15/63) seguido por la provincia de San José (11/63).

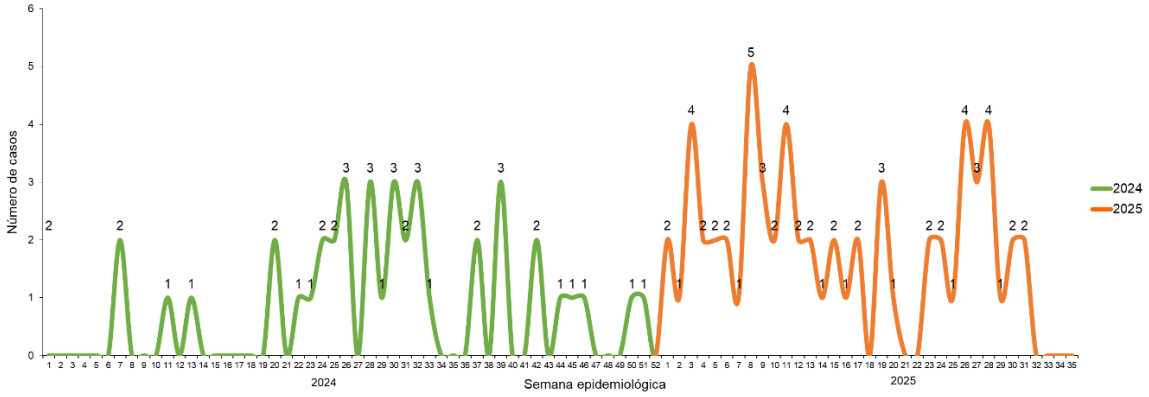
Cuadro 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasa (tasa p/100.000 habitantes) según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a la 31, 2025.

Regiones	Casos	Tasa
Total	**63**	**1,2**
Huetar Caribe	10	2,1
Central Norte	10	0,9
Chorotega	9	1,9
Central Sur	9	0,6
Brunca	7	1,8
Central Occidente	6	2,6
Pacifico Central	5	1,5
Central Este	4	0,7
Huetar Norte	3	1,1

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el cuadro 2, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del Ministerio de Salud, siendo la región Central Norte (10/63) y la Huetar Caribe (10/63) las que presentan el mayor número de casos notificados.

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 52 del 2024 al corte de la SE 31 del 2025.



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

En el gráfico 3 se puede observar el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos por SE 01 a 52 del 2024 y SE 01 a 31 del 2025, observando un aumento de los casos durante las SE 26 y 28 del 2025, con un total de 63 casos confirmados por esta enfermedad en el país.

Dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG (*Cochliomyia hominivorax*), es de suma importancia que ante la identificación de un caso sospechoso en humanos se realice el abordaje bajo el enfoque de **Una Sola Salud**, mediante coordinación interinstitucional Ministerio de Salud-Ministerio de Agricultura y Ganadería-Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)-Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) según corresponda, para identificar casos sospechosos en humanos y/o animales y puedan ser atendidos de manera oportuna.

A continuación, se brinda algunas generalidades de prevención y control de esta enfermedad:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA-MINAE) sobre la aparición de animales con gusaneras para que reciban atención oportuna